COMUNIDADE DE SANT'EGIDIO · PROGRAMA DREAM

# Telemedicina como estratégia para ampliar o acesso e apoiar a prestação de cuidados de saúde

A experiência do Programa DREAM e a sinergia com o projecto AID 012524

**F. Victor Mourana · Coordenador de Implementação da Telemedicina**
Serviços Saúde da Cidade de Maputo · 12.10.2026

UMA LIÇÃO DE OUTRO SECTOR

# Um distrito, um banco?

**15%**

dos distritos tinham um banco em 2015

**10%**

dos moçambicanos tinham conta bancária

**Moeda electrónica**

Os agentes de moeda electrónica levaram os serviços financeiros aos distritos sem agências bancárias (Banco de Moçambique, 2025)

**A telemedicina pode fazer o mesmo pela saúde: levar o serviço e onde o utente está sem o peso da infraestrutura.**

CONTEXTO

# O desafio do acesso

**34**

**milhões de habitantes**

a servir, com um rácio de especialistas por habitante muito baixo

### Poucos especialistas

Baixo rácio especialista por habitante e congestionamento nas US’s

### Infra-estruturas desiguais

Disparidades a nível nacional

### Conectividade limitada

Unidades de saúde sem internet

### Dados dispersos

Sem repositório central de dados

### Literacia digital

Níveis baixos e fraca adopção tecnológica

### Fragmentação

Investimentos duplicados e pouco sustentáveis

TELEMEDICINA

# Quatro formas de ampliar o acesso

## Teleconsultoria

**Profissional ↔ Especialista**

O clínico local obtém a opinião de um especialista à distância

## Teleconsulta

**Utente ↔ Profissional**

O utente é acompanhado sem se deslocar à unidade sanitária

## Telediagnóstico

**Dispositivo ↔ Especialista**

Exames com dispositivos ligados e apoio de IA, lidos à distância

## Teleformação

**Instituição ↔ Profissional**

Capacitação contínua dos profissionais onde trabalham

*"Até 2034, Moçambique terá um sistema de saúde abrangente e inclusivo, apoiado por uma plataforma digital de saúde segura, rumo à cobertura universal de saúde."*

Estratégia de Saúde Digital de Moçambique 2026–2034 · prioridade do PESS 2025–2034

PROGRAMA DREAM · DESDE FEVEREIRO DE 2002

# Mais de duas décadas ao lado do SNS

Prevenção, diagnóstico e tratamento **gratuitos e integrados**, em colaboração com o Ministério da Saúde.

**HIV/SIDA** **Tuberculose** **Malária** **Hipertensão**

**Diabetes** **Cancro do colo do útero**

> **Maputo, Sofala e Zambézia:** Centro para a Criança, Zimpeto, Matola II, HG Machava, Polivalente da Beira, Manga Chingussura e Quelimane

**+1.000.000**

pessoas assistidas desde 2002

**60.000**

pacientes em TARV, hipertensão e diabetes (Janeiro de 2025)

**7 + 3**

centros de saúde e laboratórios de biologia molecular

A BASE DIGITAL JÁ EXISTE

# Uma plataforma clínica 100% digital

**+1.000.000**

**pacientes registados**

na plataforma digital do Programa DREAM

### Identificador único do paciente
Cada pessoa é identificada em toda a rede

### Historial clínico completo
Todo o percurso do paciente num registo electrónico

### Totalmente desmaterializado
Sem papel: nenhum processo clínico em papel

**Porque é decisivo para a telemedicina:** o especialista à distância consulta o mesmo historial que o clínico local, a partir de qualquer ponto da rede.

EXPERIÊNCIA NO TERRENO E REGIONAL

# A DREAM está preparada para a Telemedicina

**Teleconsulta**
Acompanhamento do utente à distância

**Teleconsultoria**
Especialistas a apoiar os clínicos da rede

**Diagnóstico com IA**
Electrocardiograma e ecógrafo com inteligência artificial

**Registos clínicos digitais**
Processo clínico electrónico em toda a rede

**Experiência partilhada** pela rede DREAM em vários países africanos | **Referenciamento e Contra-Referenciamento**



ECG e ecógrafo com IA em utilização no Programa DREAM

COOPERAÇÃO ITALIANA · PROJECTO PILOTO

# Projecto AID 012524

Reforço do sistema de formação de pessoal de saúde e apoio ao desenvolvimento da telemedicina

## USD 3,5M

Financiamento da Agência Italiana para a Cooperação ao Desenvolvimento (AICS)

**Províncias de Maputo e Sofala**

**Unidades Sanitárias**

**6 periféricas + 2 Centrais**

**Formação: institutos de formação**

## 2 + 6

**Telemedicina:** hospitais centrais e unidades de saúde

**IMPLEMENTAÇÃO**

- ✓ Plataforma central de telemedicina
- ✓ Dispositivos de diagnóstico alinhados com as especialidades
- ✓ Formação em ferramentas digitais
- ✓ Suporte e help-desk

**PARCEIROS**

ITALIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION

uniss UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

AISPO

MÉDICOS COM ÁFRICA CUAMM

dream SANT'EGIDIO

DREAM + Piloto de Telemedicina

# Uma oportunidade única de sinergia

## O DREAM traz

- Plataforma digital: +1M pacientes com ID único
- 7 centros e 3 laboratórios de biologia molecular
- Experiencia regional em teleconsulta e diagnóstico com IA
- 60.000 doentes crónicos em seguimento

**Serviços clínicos por telemedicina**

integrados no SNS

## O Projecto Piloto traz

- Plataforma central de telemedicina
- Especialistas de 2 hospitais centrais
- Formação em 4 institutos de formação
- Dispositivos de diagnóstico

**Ponto de partida comum: Maputo e Sofala** — onde o DREAM tem centros e o projecto tem hospitais e unidades de saúde

MODELO OPERACIONAL PROPOSTO

# Do Centro de Saúde ao especialista

### 1. Utente
Atendido no centro DREAM ou na unidade de saúde

### 2. Exame
Com dispositivo de diagnóstico ligado

### 3. Registo
No processo clínico electrónico, com ID único

### 4. Parecer
Especialista do hospital central, via plataforma

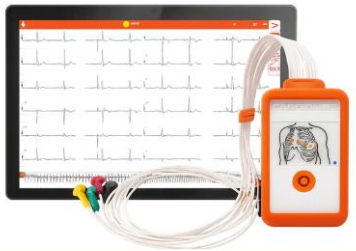
### 5. Cuidado local
Tratamento perto de casa, sem transferência evitável



**Ecógrafo**



**Estetoscópio digital**



**Electrocardiógrafo**

**INTERNET DAS COISAS MÉDICAS**

Dispositivos ligados enviam os exames directamente para o processo clínico

RESULTADOS ESPERADOS

# Impacto no acesso aos cuidados

**Levar o especialista ao doente, e não o doente ao especialista.**

**Mais eficiência e qualidade**
Decisões clínicas apoiadas por especialistas

**Menos transferências | Menos peso laboral**
Mais doentes tratados na unidade de origem

**Menos barreiras geográficas**
Cuidados especializados à distância

**Custos mais baixos**
Na prestação de cuidados e na formação

**Sustentabilidade**
Plano de sustentabilidade desde o início

PESSOAS · PROCESSOS · TECNOLOGIA

# Condições para o sucesso

## Pessoas

**Lideram o impacto**

Formação, literacia digital e gestão da mudança

**Sem pessoas:** baixa adopção e investimentos subutilizados

## Processos

**Governam a execução**

Protocolos de teleconsultoria integrados na rede de referência

**Sem processos:** fraca sustentabilidade e baixa qualidade

## Tecnologia

**Possibilita a visão**

Conectividade, plataforma interoperável e dispositivos

**Sem tecnologia:** frustração, ineficiência e custos elevados

### PRÓXIMOS PASSOS PROPOSTOS COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE

- ✓ Priorizar unidades sanitárias
- ✓ Integrar na rede de referência
- ✓ Apoiar a conectividade
- ✓ Co-liderar formação e supervisão

# DREAM e Telemedicina: da plataforma digital à prestação de cuidados por telemedicina

**+1.000.000 pacientes**
Numa plataforma 100% digital, sem papel

**USD 3,5M da Cooperação Italiana**
Para formação e telemedicina

**Maputo e Sofala**
Ponto de partida comum para escalar no SNS

## Muito obrigado!